Pathologies du système nerveux

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

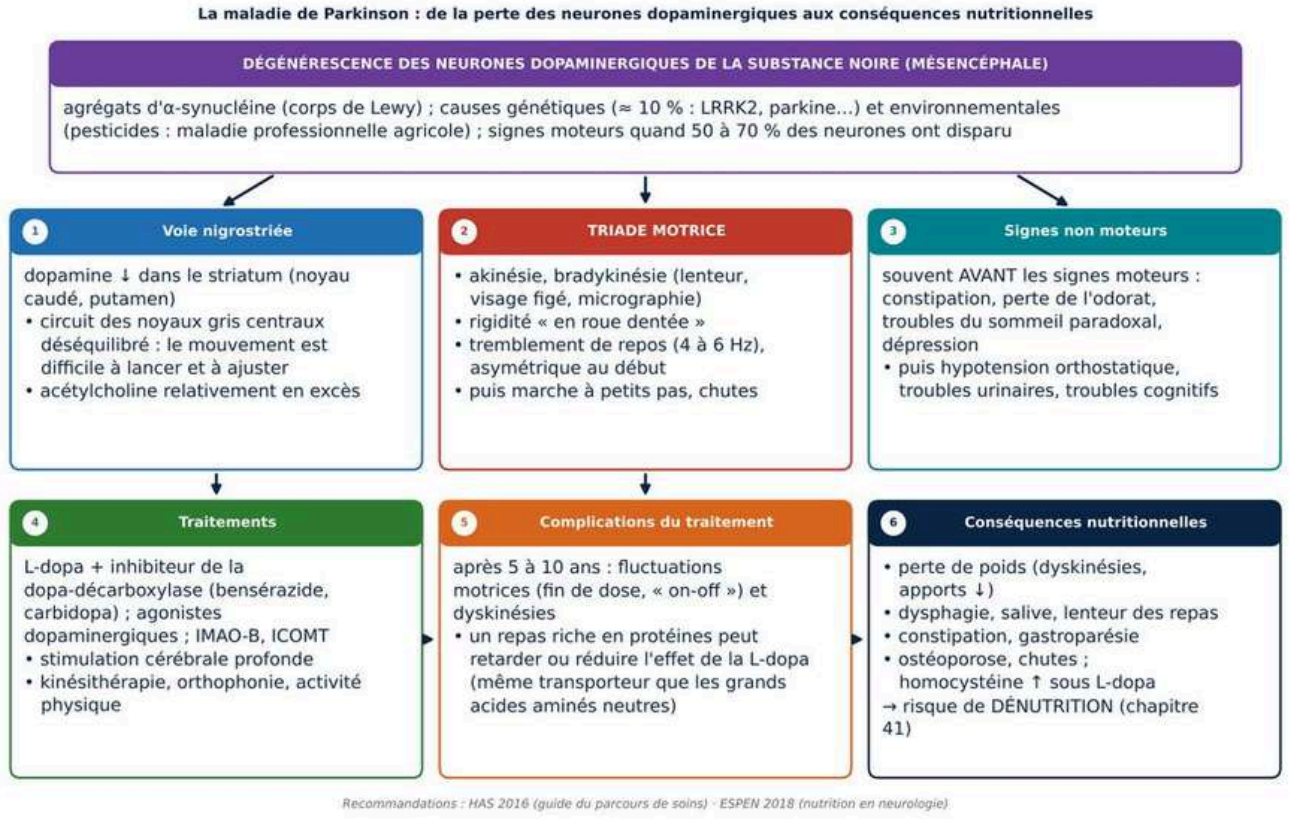


Figure 37.1 – La maladie de Parkinson : de la perte des neurones dopaminergiques aux signes moteurs et non moteurs, aux traitements et aux conséquences nutritionnelles (37.3.1)

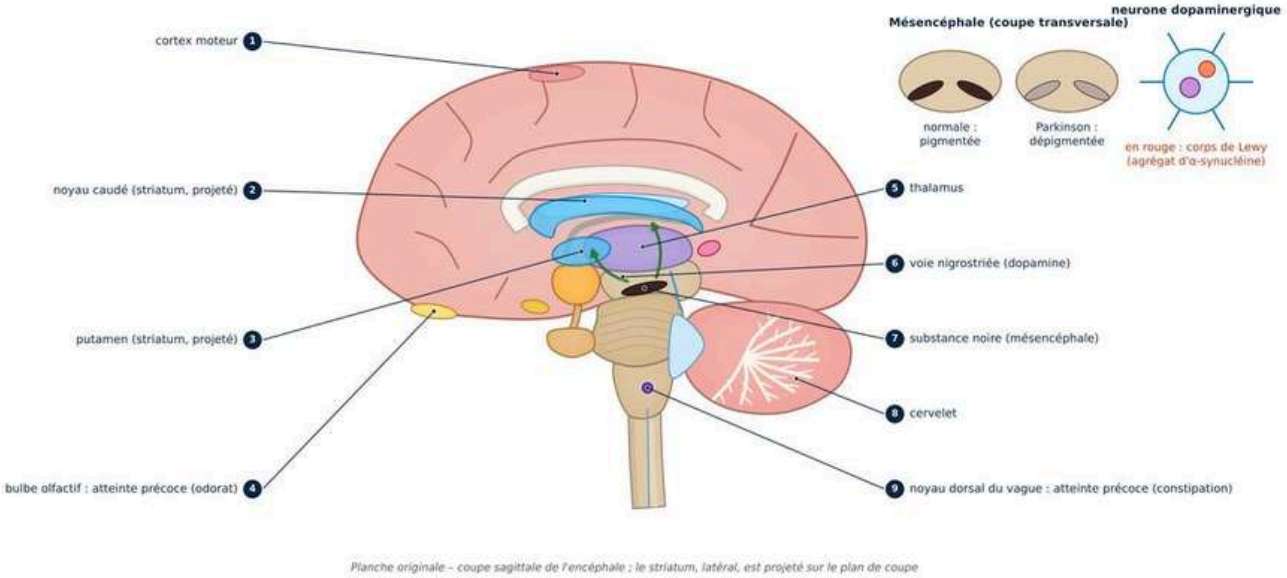


Figure 37.2 – Planche – coupe sagittale de l'encéphale : la substance noire du mésencéphale, la voie nigrostriée et le striatum (projeté) ; à droite, la substance noire normale et dépigmentée, et un neurone avec un corps de Lewy (37.3.1)

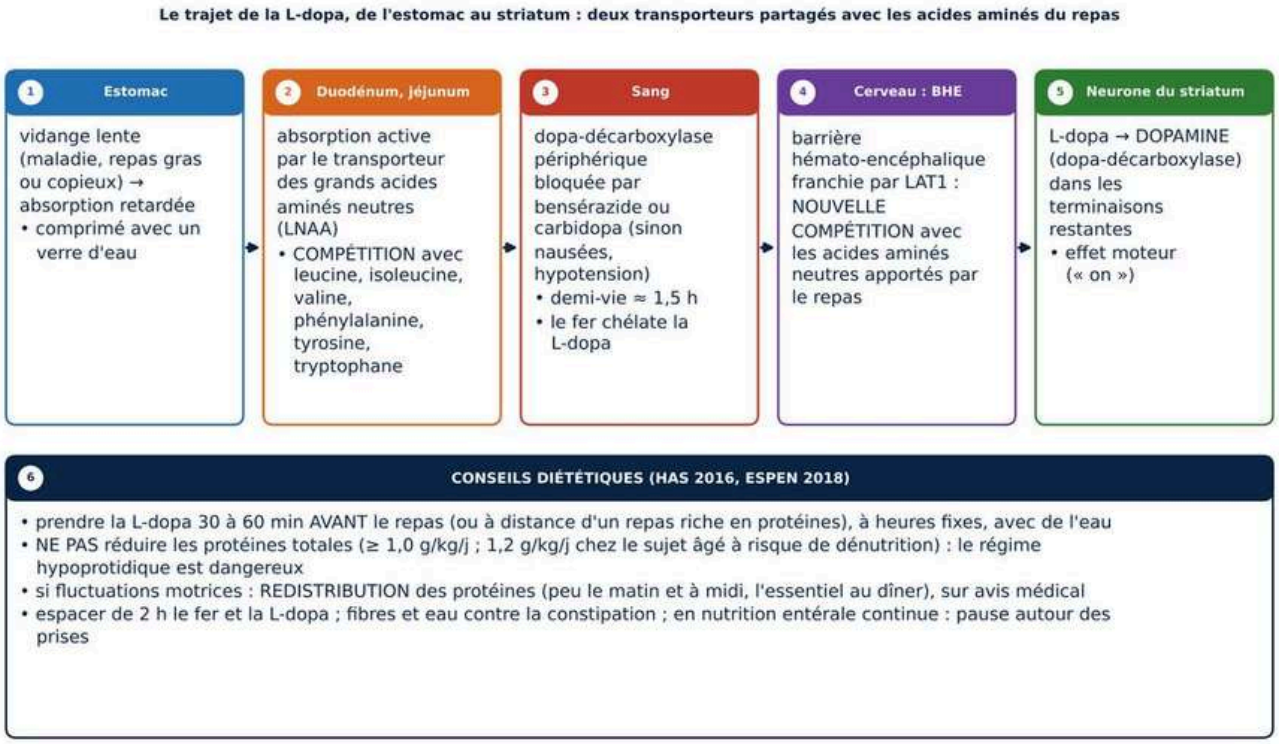


Figure 37.3 – Le trajet de la L-dopa, de l'estomac au striatum : deux transporteurs partagés avec les acides aminés neutres du repas, et les conseils diététiques qui en découlent (37.3.1)

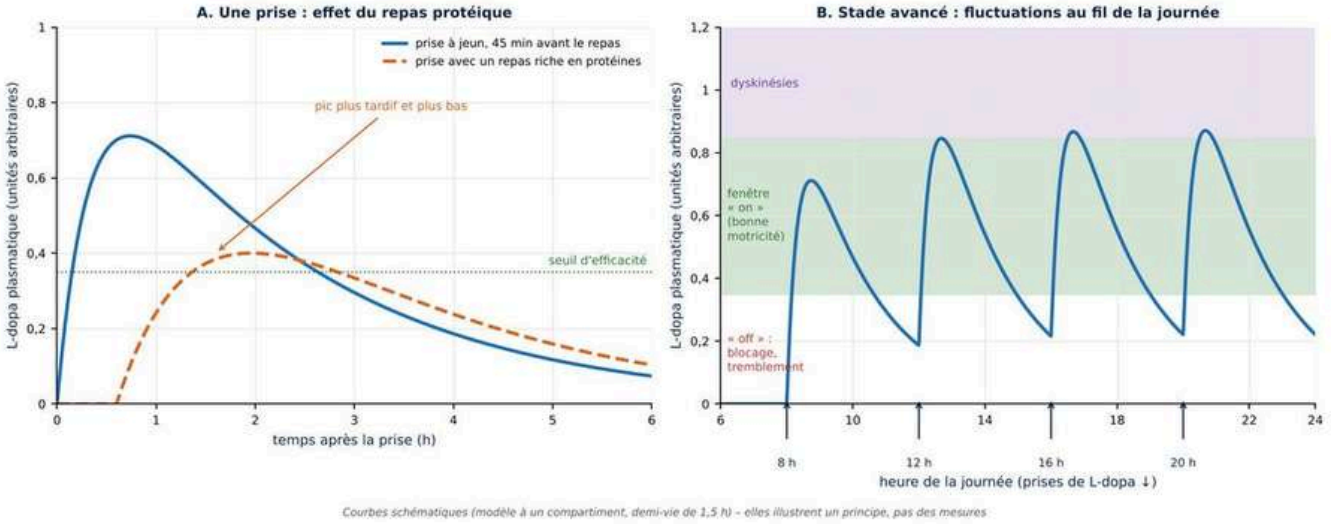


Figure 37.4 – Courbes schématiques de la L-dopa plasmatique : (A) une prise à jeun ou avec un repas riche en protéines ; (B) au stade avancé, quatre prises par jour et une fenêtre thérapeutique étroite (« on », « off », dyskinésies) (37.3.1)

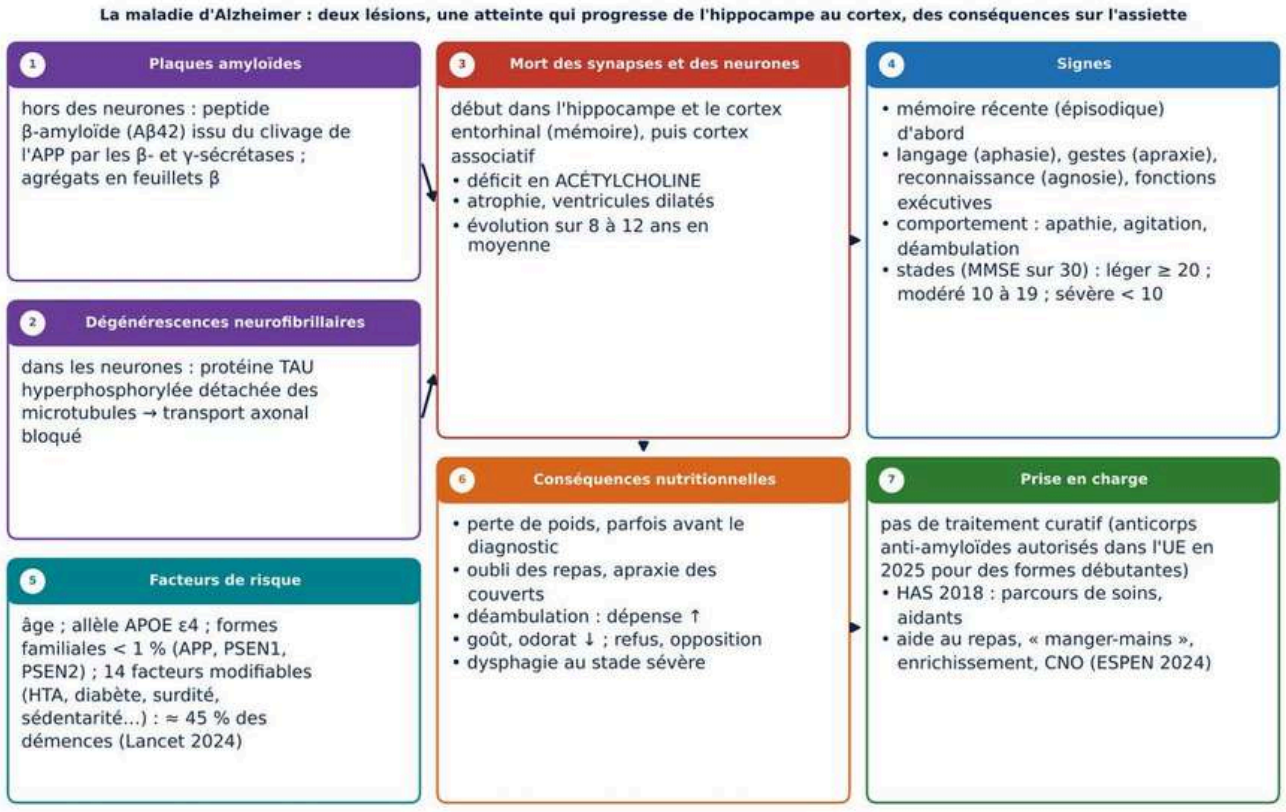


Figure 37.5 – La maladie d'Alzheimer : deux lésions, une atteinte qui progresse de l'hippocampe au cortex associatif, les facteurs de risque, les conséquences nutritionnelles et la prise en charge (37.3.1)

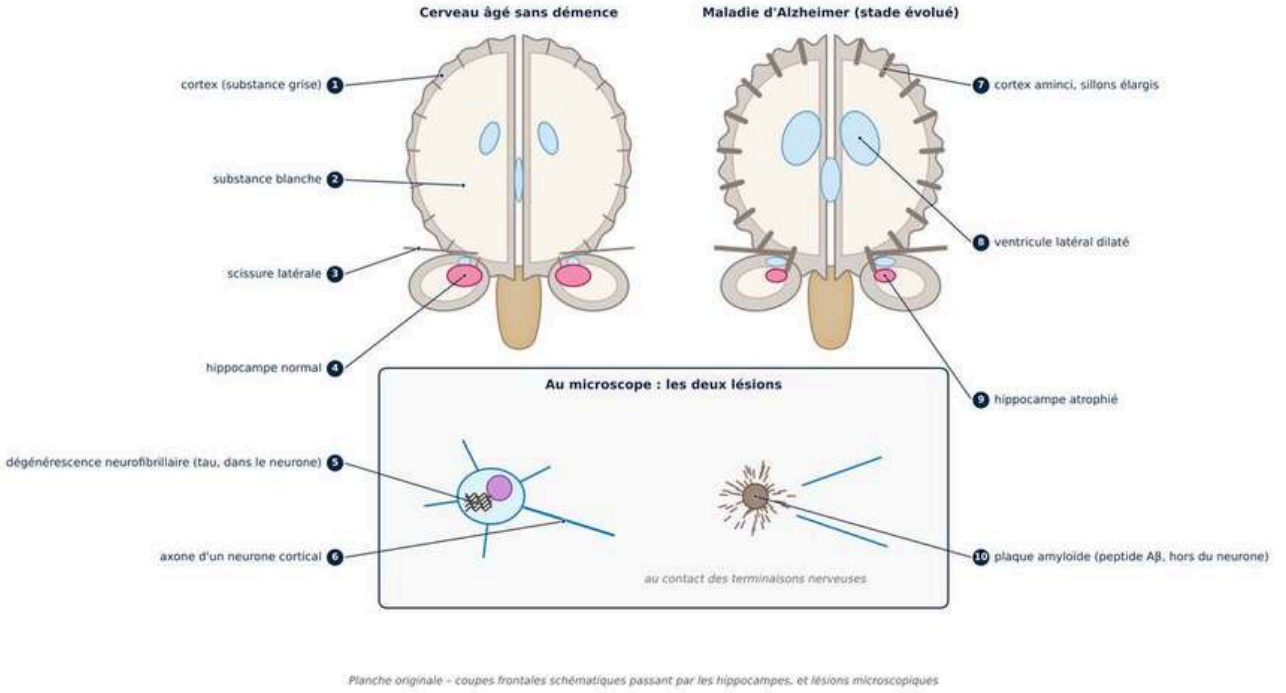


Planche originale – coupes frontales schématiques passant par les hippocampes, et lésions microscopiques

Figure 37.6 – Planche – coupes frontales schématiques passant par les hippocampes, chez un sujet âgé sans démence et au stade évolué de la maladie d'Alzheimer, et les deux lésions microscopiques (37.3.1)



Figure 37.7 – L'épilepsie : une rupture de l'équilibre entre excitation et inhibition, les types de crises, les causes, les traitements et les liens avec la nutrition (37.3.2)



Figure 37.8 – Le régime cétogène : de l'assiette au neurone, la cétogenèse remplace le glucose par les corps cétoniques ; efficacité, surveillance, indications et contre-indications (37.3.2)

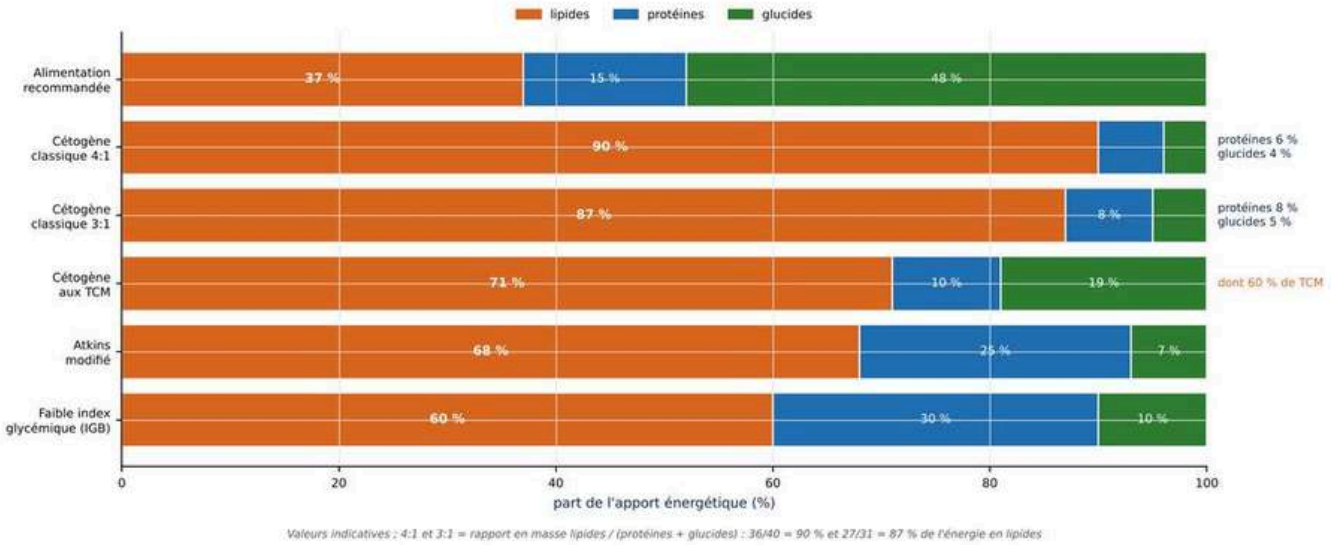


Figure 37.9 – Répartition de l'énergie (en %) entre lipides, protéines et glucides dans l'alimentation recommandée et dans les différents régimes cétogènes (valeurs indicatives) (37.3.2)

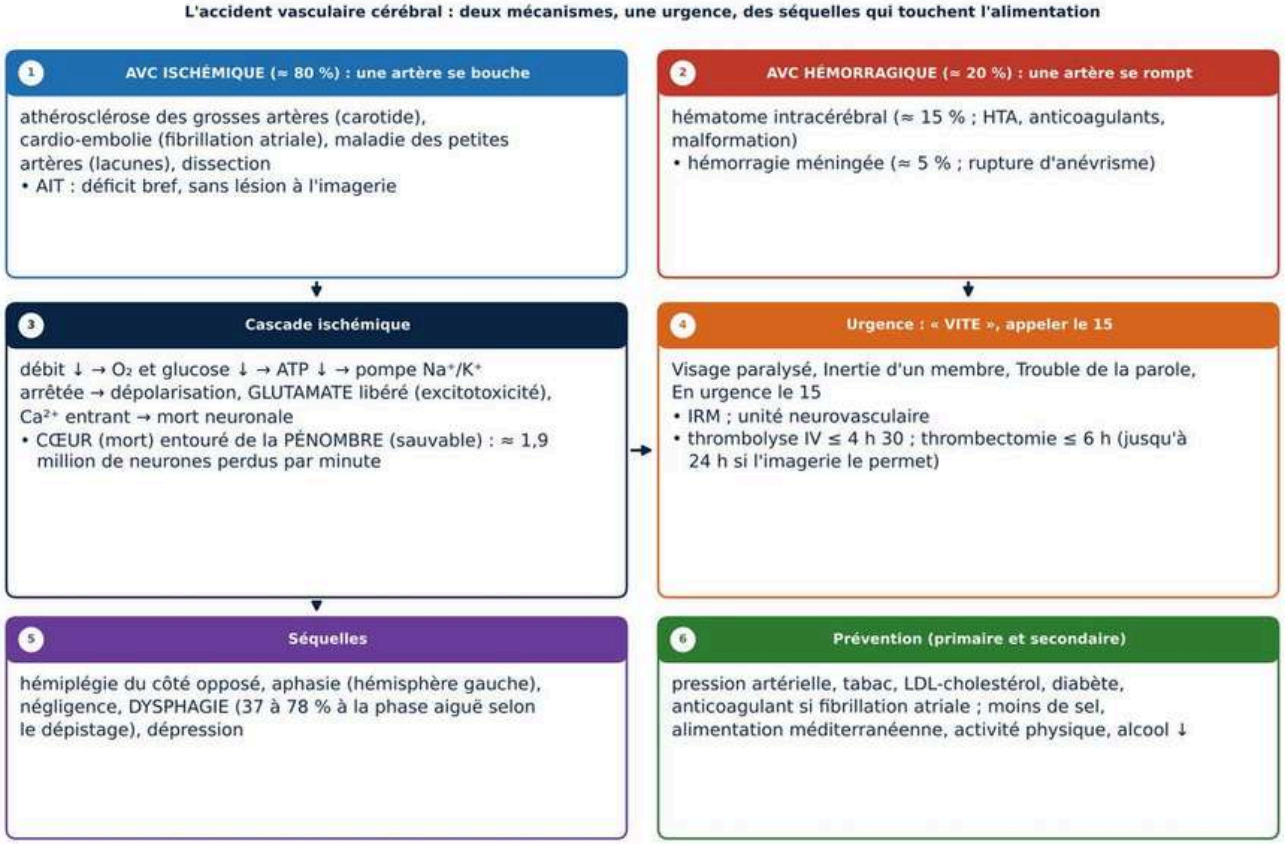


Figure 37.10 – L'accident vasculaire cérébral : les deux mécanismes (ischémique et hémorragique), la cascade ischémique, l'urgence, les séquelles et la prévention (37.3.3)

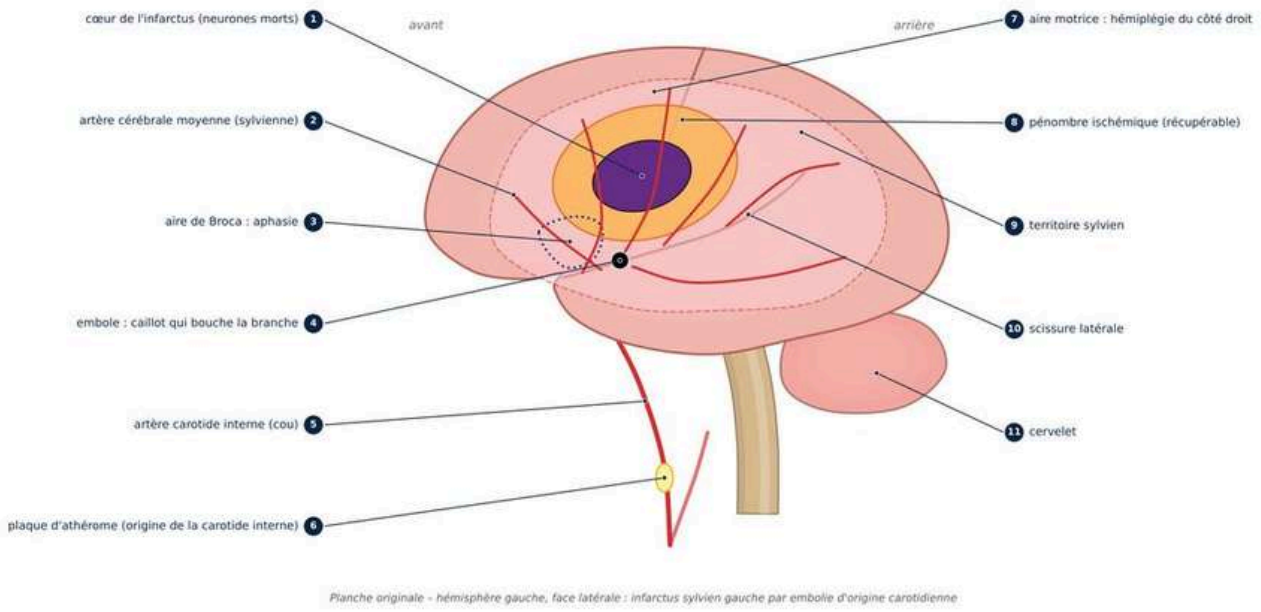


Figure 37.11 – Planche – hémisphère gauche, face latérale : infarctus sylvien gauche par embolie d'origine carotidienne (cœur de l'infarctus, pénombre, territoire de l'artère cérébrale moyenne et aires fonctionnelles touchées) (37.3.3)

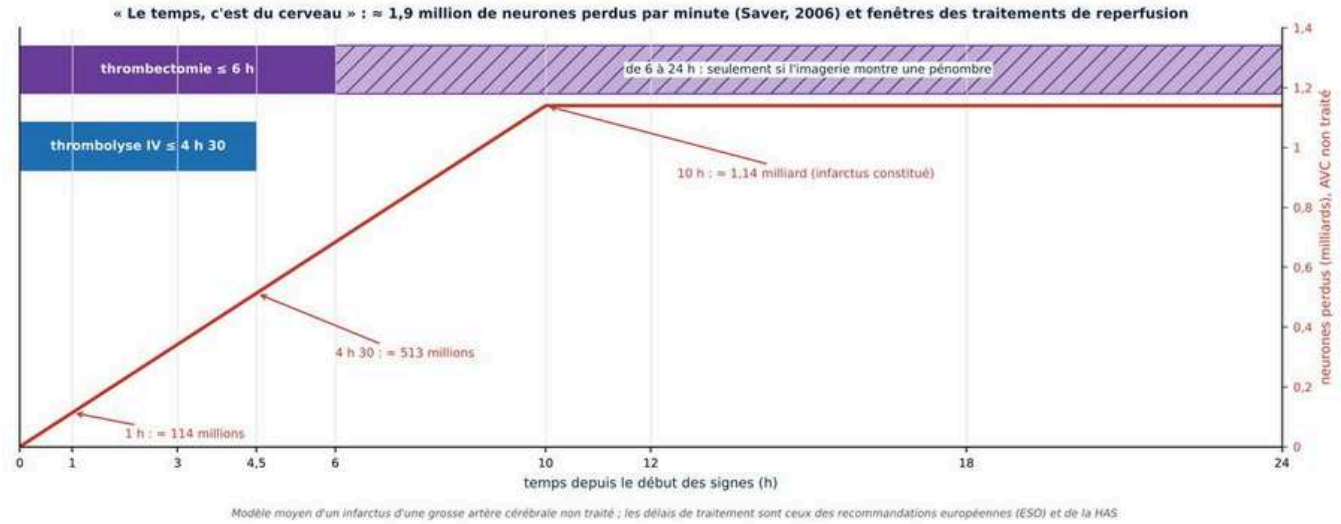


Figure 37.12 – « Le temps, c'est du cerveau » : neurones perdus en fonction du temps dans un AVC ischémique d'une grosse artère non traité, et fenêtres des traitements de reperfusion (37.3.3)

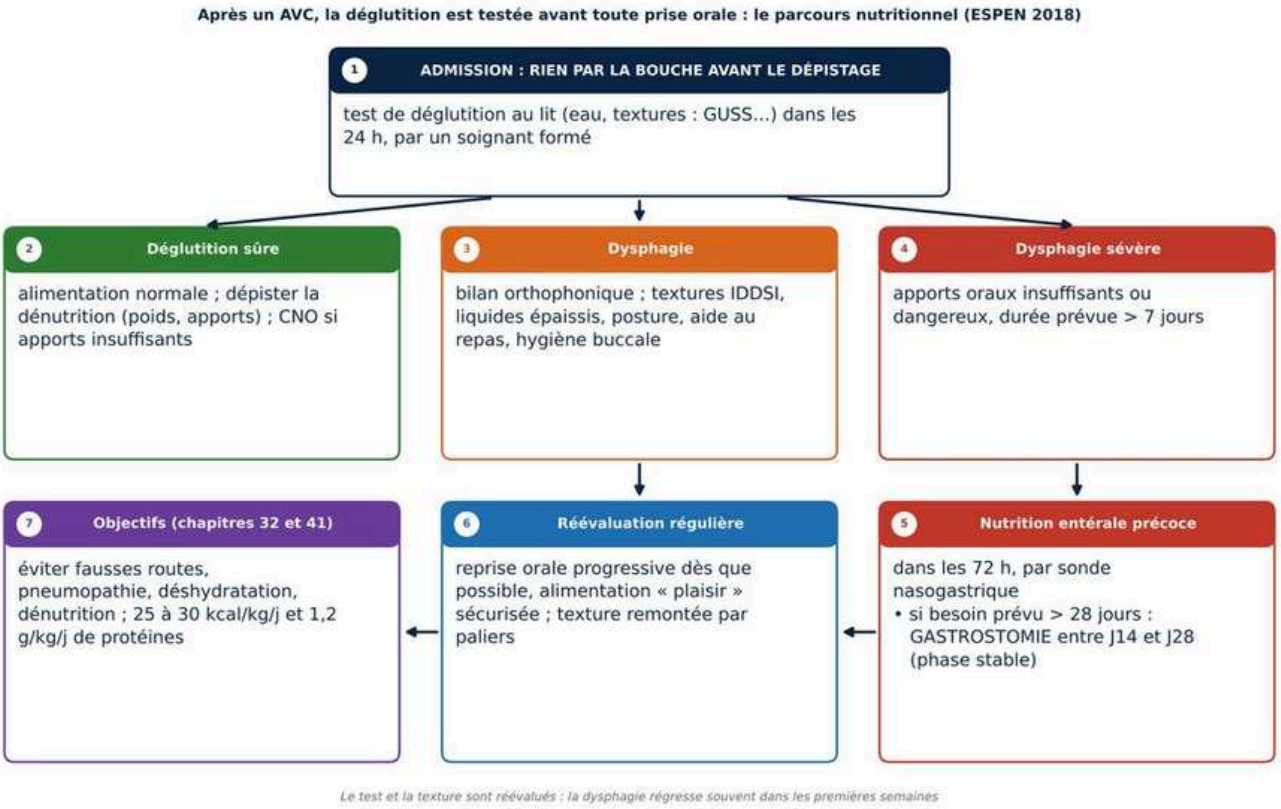


Figure 37.13 – Après un AVC, la déglutition est testée avant toute prise orale : le parcours nutritionnel, du dépistage aux textures adaptées et à la nutrition entérale (ESPEN 2018) (37.3.3)



Figure 37.14 – Le cadre international IDDSI : huit niveaux de 0 à 7 pour les boissons (0 à 4) et les aliments (3 à 7), avec les tests qui permettent de vérifier chaque niveau (37.3.3)

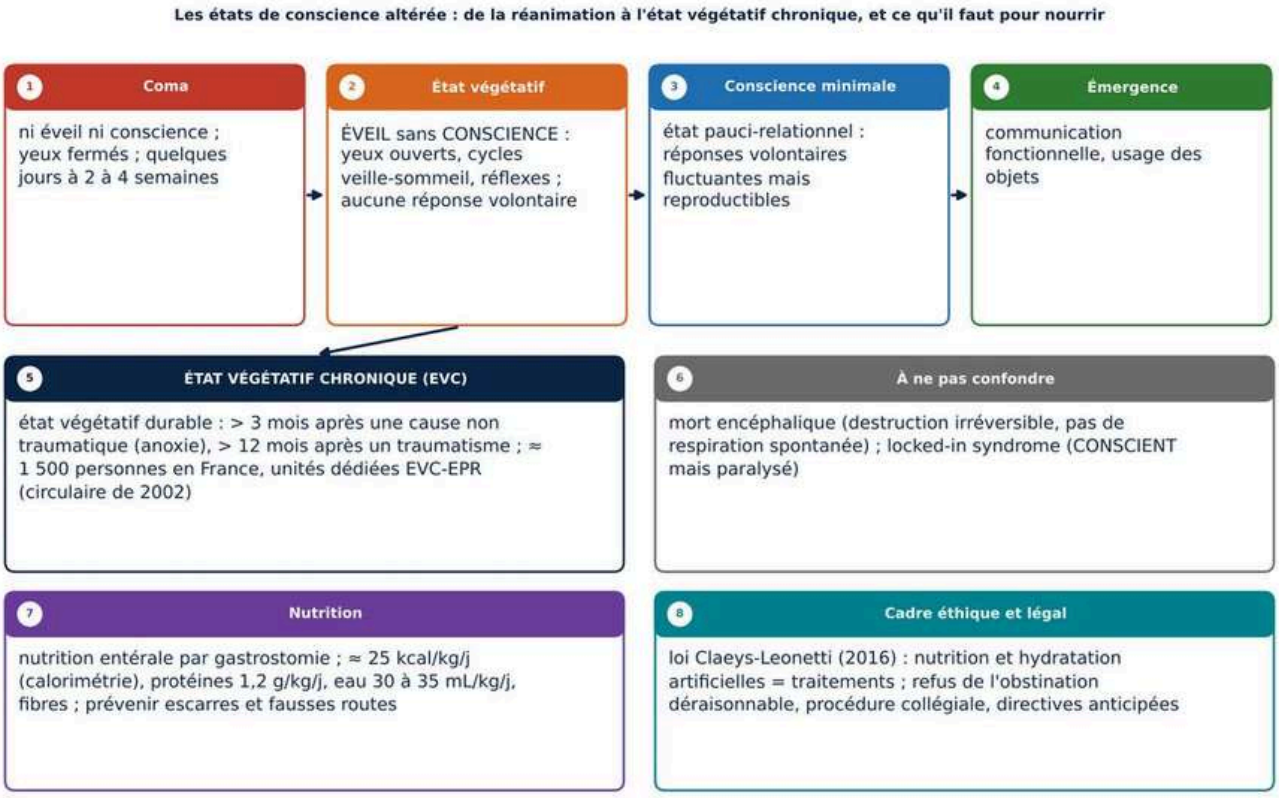


Figure 37.15 – Les états de conscience altérée : coma, état végétatif, état de conscience minimale, émergence ; l'état végétatif chronique, les diagnostics différentiels, la nutrition et le cadre éthique et légal (37.3.4)

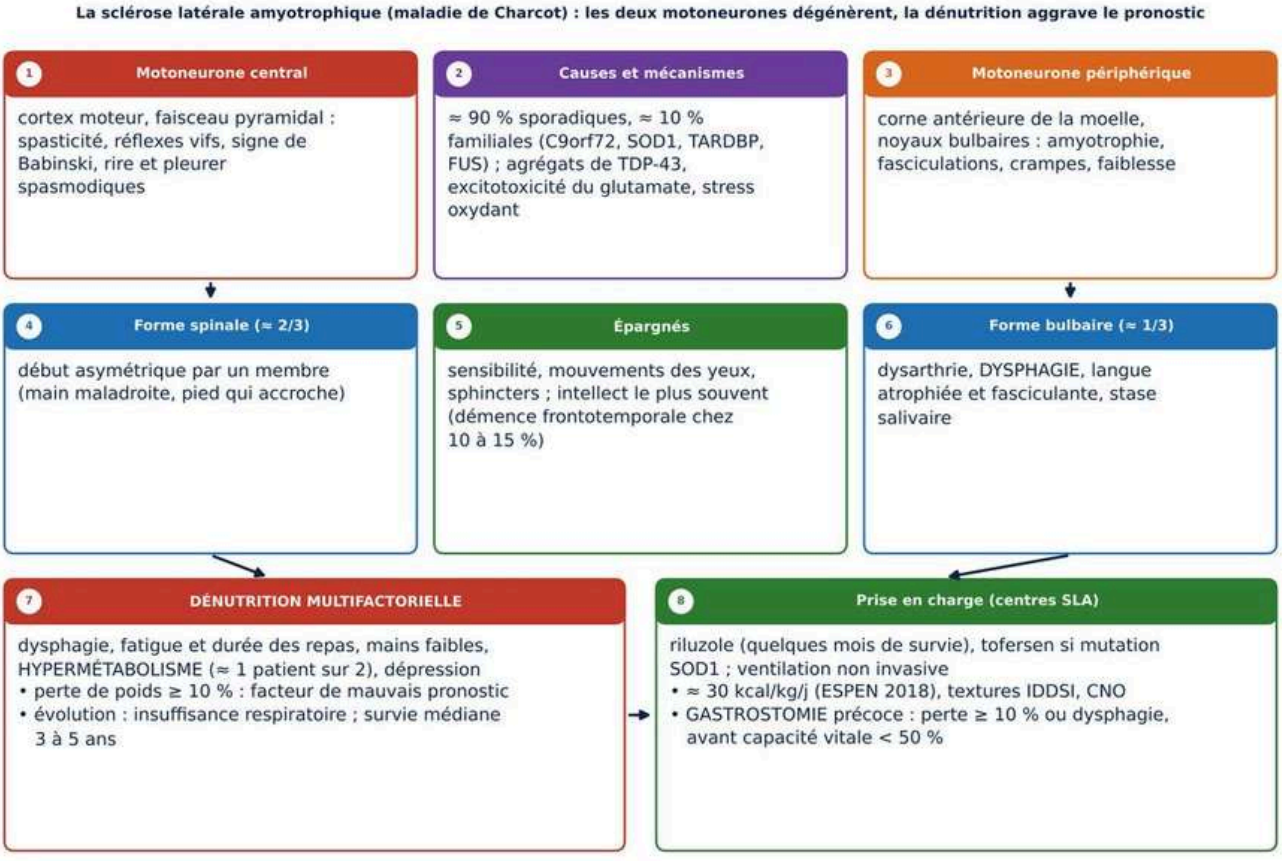


Figure 37.16 – La sclérose latérale amyotrophique (maladie de Charcot) : atteinte des deux motoneurones, formes spinale et bulbaire, fonctions épargnées, dénutrition multifactorielle et prise en charge (37.3.5)

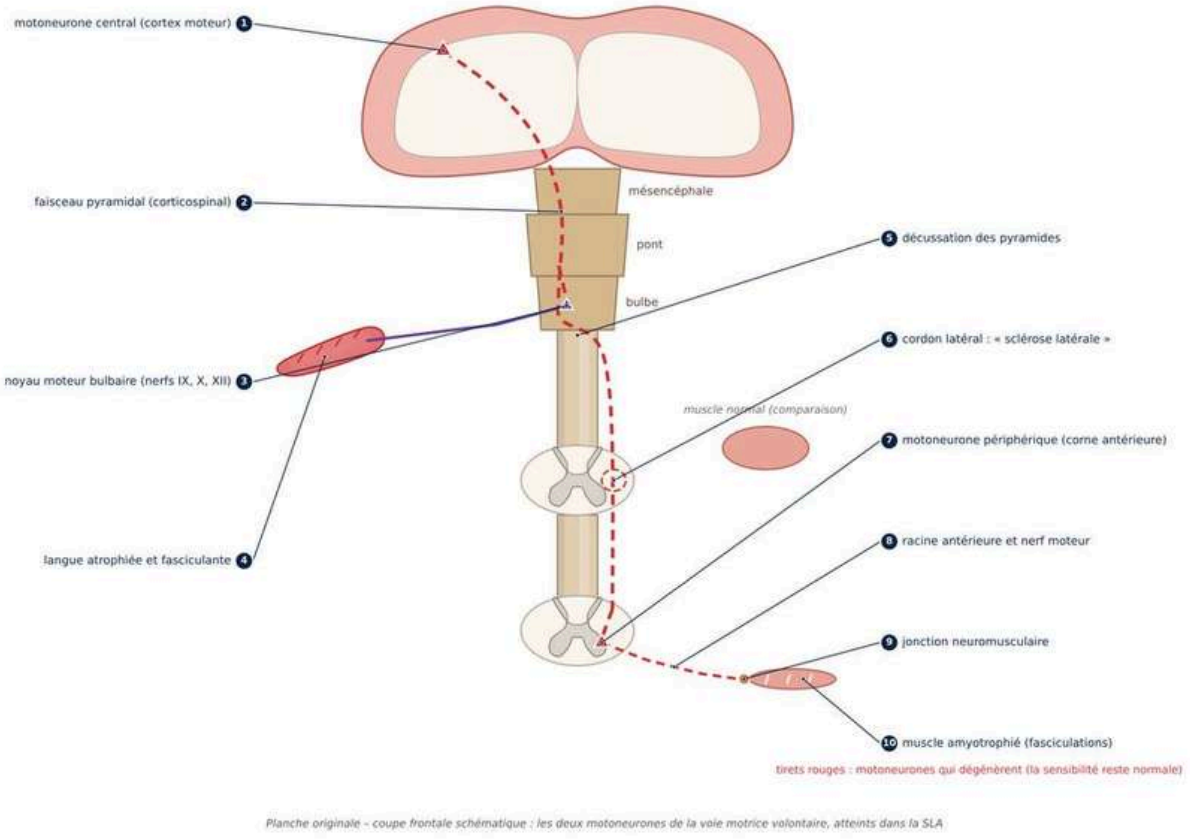


Figure 37.17 – Planche – coupe frontale schématique de la voie motrice volontaire : motoneurone central (cortex, faisceau pyramidal) et motoneurone périphérique (noyau bulbaire, corne antérieure, nerf, muscle), atteints dans la SLA (37.3.5)

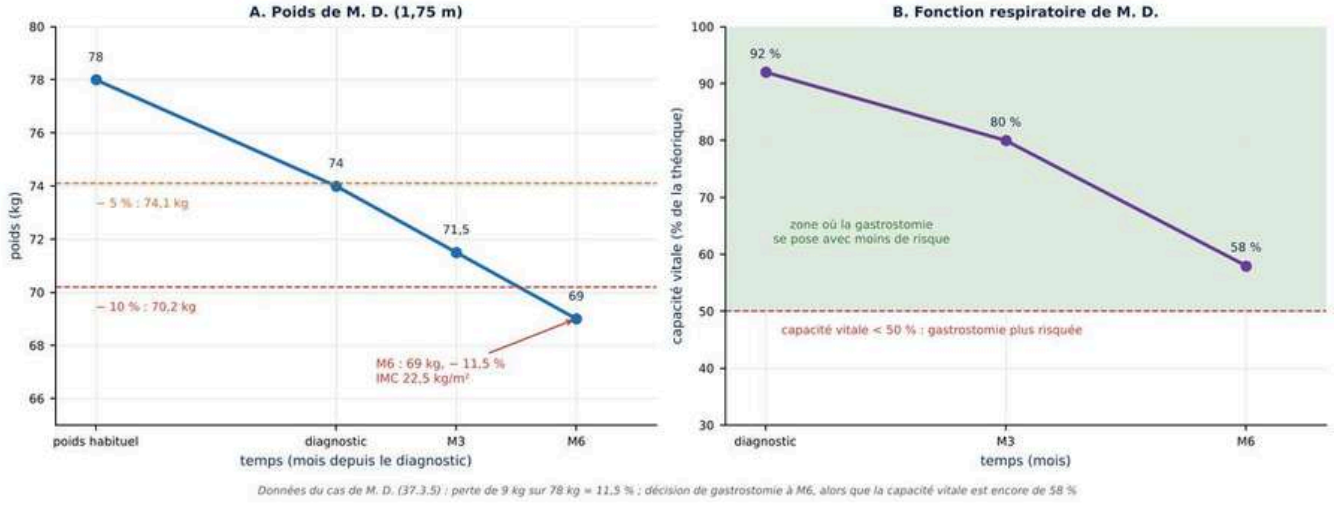


Figure 37.18 – Suivi de M. D., 64 ans, atteint de SLA : (A) poids depuis le poids habituel, avec les seuils de perte de 5 % et 10 % ; (B) capacité vitale en pourcentage de la théorique, et zone où la gastrostomie se pose avec moins de risque (37.3.5)